



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رضا عبدالحميد عبدالله --
 المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : عين شمس العنوان : --
 رقم البطاقة : 25404290101369 رقم التليفون :
 العمر (تاريخ الميلاد) : 29-04-1954 المهنة : بدون عمل تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
 الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
 نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
 الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)
 المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129]
 قسم العلاج :
 الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
 الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
 الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
 أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
 وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
 كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
 تعتمد صحة البيانات المرفقة
 رئيس اللجنة ومدير
 المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض
 بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى : قسم :
 جهة العلاج : نفقات :
 ملاحظات :

ختم
 شعار الجمهورية

مدير عام
 مديرية الشؤون الصحية

رئيس
 المجلس الطبي المتخصص

--

Name: -- رضا عبدالحميد عبدالله -- National ID: 25404290101369	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- :-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- :--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard , USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : رضا عبد الحميد عبد الله	Analysis ID : 1096895
Age : 72 Y : 4 M : 2 D	Gender : Female
Referred By Prof. Dr. : بنى عز العرب	Conf. Code : 2582
Clinical Diagnosis : Left breast mass.	
Nature of Specimen : Core biopsy.	
Receiving Date : 2026-09-19	Patient ID : 799417

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Multiple tan tissue cores, the longest measured 0.5 cm long, totally submitted.

Microscopic :

Serial sections examined from the specimen received revealed cores of breast tissue showing infiltrating tumor tissue formed of monotonous discohesive malignant epithelial cells with high nucleo/cytoplasmic ratio, mostly arranged in single cell strands and indian file pattern, and surrounded by little desmoplasia.
Lobular carcinoma insitu component 15%.
There is insignificant peritumoural lymphocytic infiltrate.
No necrosis.

Diagnosis :

Left breast mass, Core biopsy,
INFILTRATING CLASSIC LOBULAR CARCINOMA, GRADE 2.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

Shady Elia

Elia Anis

This report is electronically signed , any abrasion or modification would render it void .



عصارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٠١٢١٢٩٤٥١١٥ - ٠١٢٨٧٠٠٥٢١٧ - ٠١٢٨٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٩٠٩٣٥

Name : Reda Abdelhameed
Abdallah

Date: 14/09/2026

Clinical summary: 72 yrs old female with left breast lump.

**DIGITIZED BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY
AND COMPLEMENTARY ULTRASONOGRAPHY FOR
BOTH BREASTS REVEALED:**

- Scattered fibroglandular mammary parenchyma; ACR b.
- Left UOQ zone c irregular shaped ill-defined spiculated lesion
- No right breast masses, distortion or asymmetry detected
- No spiculations or suspicious microcalcifications.
- **Complementary ultrasonography revealed:**
- Correlating with mammography. Left UOQ irregular spiculated hypoechoic heterogenous lesion seen at 2 o'clock about 6 cm from nipple and 8 mm from overlying skin. It measures 2.2x 1.8 cm No abnormal vascularity detected on color Doppler.
- No dilated retro areolar ducts
- Normal skin thickness and contour.
- Bilateral nonspecific axillary nodes with preserved fatty hilum and thin cortex.

OPINION:

Left UOQ suspicious lesion (BIRADS 4) for further histopathological correlation

Normal study of right breast (BIRADS 1)

Best regards

Dr. Heba Ahmad ,MD



L A B S

Collection Date: 16/09/2026	Patient Name: الاستاذة / رضا عبدالحمن عبد الله
Review Date: 16/09/2026	Patient No.: 114-35425
	Accession No.: 114260910722
	Age: 72Y

HEMATOLOGY UNIT			
Test Name	Result	Unit	Reference Interval
Prothrombin Time and Conc.			
Control	12.4	Seconds	
Patient Time	11.4	Seconds	
Concentration	115	%	70 - 140
INR	0.92		Less Than 1
Bleeding Time	1 : 00	min	1 - 4
Clotting Time (Lee-White)	7 : 00	min	4 - 10



Pt. Branch: دار السلام

Page 1 of 1

Reviewed By:
Dr. Ashraf Bakiyeh

طبيب المختبر: سيد حسب التلي الاخصاري
سيد حسب التلي 310131



L A B S

Collection Date: 16/09/2026
Review Date: 16/09/2026

الاسم: رفسا عبدالحميد عبدالله
Patient Name: 114-35425
Patient No.: 114260910722
Accession No.: 72Y
Age:

HEMATOLOGY UNIT

Complete Blood Picture (CBC)

Test Name	Result	Unit	Reference Interval
Haemoglobin	11.00	g/dL	12 - 15
Hematocrit	32.9	%	36 - 46
Red cell count	4.11	$\times 10^6 / \mu\text{L}$	3.8 - 4.8
MCV	80.0	fL	83 - 101
MCH	26.8	pg	27 - 32
MCHC	33.5	g/dL	31.5 - 34.5
RDW	16.8	%	11.6 - 14
Platelet Count	288	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	150 - 410
T.L.C	7.8	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	4 - 10

Differential Count	Percent Values	Absolute Values
Basophils	1 % 0 - 2	0.1 $\times 10^3 / \mu\text{L}$ 0.02 - 0.1
Eosinophils	2 % 1 - 6	0.2 $\times 10^3 / \mu\text{L}$ 0.02 - 0.5
Stab	0 % 0 - 7	0.0 $\times 10^3 / \mu\text{L}$
Segmented	57 % 40 - 80	4.4 $\times 10^3 / \mu\text{L}$ 2 - 7
Lymphocytes	33 % 20 - 40	2.6 $\times 10^3 / \mu\text{L}$ 1 - 3
Monocytes	7 % 2 - 10	0.5 $\times 10^3 / \mu\text{L}$ 0.2 - 1
MPV	8.5 fL 8 - 12	

Comments : Mild microcytic hypochromic anemia with mild anisocytosis of RBCs.
Platelets are adequate.
WBCs are within normal limits.
Iron profile is recommended.



Reviewed By:

Dr. Ashraf Saleem

Pt. Branch: السلام

Page 1 of 1

طابع الإصدار: سيد حسب القي الاصداري
Printed by: سيد حسب القي الاصداري
310131



L A B S

Collection Date: 16/09/2026
Review Date: 16/09/2026

الاسم: رضا عبدالحمن عبدالله
Patient Name: رضا عبدالحمن عبدالله
Patient No.: 114-35425
Accession No.: 114260910722
Age: 72Y

IMMUNOLOGY UNIT

Test Name	Result	Unit	Reference Interval
CEA, Serum	3.3	ng/mL	Up to 5.0
CA 15-3, Serum	10.7	U/mL	Up to 28.5

✓



Pt. Branch: دار السلام

Page 1 of 1

Reviewed By:
Dr. Ashraf Salegho

Printed By: هاجر الاصلري سيد حسب التبي الاصغري
سيد حسب التبي 310131



L A B S

Collection Date: 16/09/2026
Review Date: 16/09/2026

الاسم: رضا عبدالحسين عبد الله
Patient No.: 114-35425
Accession No.: 114260910722
Age: 72Y

CHEMISTRY UNIT

Test Name	Result	Unit	Reference Interval
Glycated Haemoglobin (HbA1c), EDTA	6.2	%	< 5.7 Normal Range 5.7 - 6.4 Prediabetic ≥ 6.5 Diabetic
ALT (SGPT), Serum	17	U/L	Less Than 50
AST (SGOT), Serum	22	U/L	Less Than 34
Bilirubin (Total), Serum	0.44	mg/dL	0.3 - 1.2
Creatinine, Serum	1.59	mg/dL	0.55 - 1.02



Pt. Branch: طبر السلام

Page 1 of 1

Reviewed By:

Dr. Ashraf Saleh

طبر السلام: سيد حسب الطبي الاخصاري
Printed by: سيد حسب الطبي
310131